

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077502-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ALINE LUCIO LESSA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E OUTROS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - SAÚDE - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE MOFETILA PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE SISTÊMICA CUTÂNEO-DIFUSA COM QUADRO CUTÂNEO EXTENSO E DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR - OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO ALCANÇA AQUELES DE USO *OFF-LABEL* - TEMA 106 STJ - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, confirmando a decisão do Ev. 4 destes autos, a fim de manter a decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Após o trânsito em julgado, proceda-se à devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5077502-18.2024.4.02.5101

510014998715 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077502-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ALINE LUCIO LESSA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal, nos autos do processo nº 5073304-35.2024.4.02.5101 (Ev. 9), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, objetivando que os réus sejam compelidos solidariamente a fornecerem o medicamento Micofenolato de Mofetila.

Sustenta a recorrente, em síntese, que necessita do medicamento, com urgência, porque doença já está em fase muito avançada, com sintomas de espessamento difuso na pele, feridas nas mãos, manchas e aspecto de deformidade na face, além de fibrose com destruição da arquitetura pulmonar, com perda irreversível de volumes pulmonares e redução importante da capacidade pulmonar, com alto risco de mortalidade.

Pela decisão do Ev. 4, foi negada a antecipação de tutela recursal.

Apresentadas contrarrazões pela União.

É o relato do necessário.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos às pessoas que não tenham condições financeiras para custear sua aquisição.

Inicialmente, parece-me que, uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Embora haja um dever solidário dos entes federados em prover uma assistência integral à saúde, tal qual exposto anteriormente, não se ignora que uma mesma doença possa ser tratada de diversas formas e com diferentes medicamentos, sendo a definição do tratamento adequado a cada caso uma questão de ordem médica e não propriamente de ordem jurídica. Assim, a escolha da alternativa terapêutica adequada a cada doença, quando seu tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde, cabe em princípio ao corpo médico do sistema único de saúde, tal qual estruturado na legislação, devendo tais escolhas ser em princípio prestigiadas pelo Poder Judiciário, na medida em que embasadas em estudos técnicos na área de medicina.

No entanto, embora a escolha do administrador, com base em estudos técnicos, deva ser em princípio prestigiada, não está o Judiciário a ela absolutamente adstrito ou impedido de atuar supletivamente, caso haja nos autos indicativo de que a terapêutica oferecida não tem se mostrado adequada ou suficiente, havendo outras alternativas disponíveis. Entender de modo contrário seria retirar do Poder Judiciário a atribuição de tutelar os direitos fundamentais, em flagrante violação à Constituição.

É de salientar que, no tocante à possibilidade de fornecimento de medicamentos não constantes de listas do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Recurso Especial 1.657.156, vinculado ao tema repetitivo 106, firmou a seguinte tese:

"4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento".

Extrai-se dos laudos médicos do Evento 1, Anexo 2, Página 24 dos autos do processo nº 5073304-35.2024.4.02.5101, que a parte autora possui diagnóstico de Esclerose Sistêmica Cutâneo-Difusa, com o início dos sintomas em 2011. Após tratamentos inadequados, foi atendida pela Reumatologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto em 2020, sendo constatado que a doença estava avançada com quadro cutâneo extenso e Doença Intersticial Pulmonar importante. Foi indicado o uso de Micofenolato de Mofetila após período de tratamento da tuberculose latente.

No Formulário Médico do Evento 1, Anexo 2, Páginas 13/21 dos autos principais, é informado que houve ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS. Contudo, não foi especificado quais medicamentos teriam sido utilizados.

No parecer do Evento 7 dos autos principais, o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (NAT) apresentou as seguintes informações:

5. De acordo com literatura consultada, o **Micofenolato de Mofetila** tem sido utilizado na **esclerose sistêmica** tanto em pacientes com acometimento cutâneo quanto pulmonar. O Metotrexato é a primeira opção terapêutica para o espessamento cutâneo progressivo nos pacientes com esclerose sistêmica. A Ciclofosfamida, o **Micofenolato de Mofetila** e o Rituximabe podem representar opções terapêuticas nos casos não responsivos ao tratamento com Metotrexato⁶.

6. No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado, insta mencionar que **Micofenolato de Mofetila 500mg** é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) aos pacientes que se enquadram nos critérios de inclusão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elaborados pelo Ministério da Saúde, e conforme o disposto na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem as normas de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS.

➤ **Micofenolato de Mofetila 500mg** é disponibilizado pelo CEAF perfazendo o grupo de financiamento 1A do referido componente: *medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estado e Distrito Federal*^{7,8}.

7. Os medicamentos do CEAF somente serão autorizados e disponibilizados para as doenças descritas na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) contempladas. Assim, **a doença do demandante, a saber esclerose sistêmica não está dentre as contempladas para a retirada do medicamento pela via do CEAF, impossibilitando a obtenção do Micofenolato de Mofetila 500mg de forma administrativa.**

8. O medicamento **Micofenolato de Mofetila possui registro válido** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), contudo **não foi avaliado** pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC⁹ para o tratamento da **esclerose sistêmica**.

9. Para o tratamento da **Esclerose Sistêmica**, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)¹, através da Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 16, de 10 de agosto de 2022. Por conseguinte, a Secretaria de Estado de Saúde fornece por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) os seguintes medicamentos: Metotrexato 2,5mg (comprimido) e 2,5mg/mL (solução injetável), Azatioprina 50mg (comprimido), Hidroxicloroquina 400mg (comprimido) e Sildenafil 25mg e 50mg (comprimido).

10. De acordo com o PCDT¹ supracitado, para o tratamento medicamentoso das manifestações pulmonares a ciclofosfamida é considerada a primeira linha terapêutica nas manifestações pulmonares da ES, a azatioprina pode ser uma opção de tratamento para pacientes que apresentam hipersensibilidade à ciclofosfamida.

11. Cabe ressaltar que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Esclerose Sistêmica faz referência ao **Micofenolato de Mofetila**, justificando a não recomendação uma vez que o uso de micofenolato (de sódio ou mofetila) no tratamento das

Nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.657.156, a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, pelos entes públicos, não alcança os medicamentos sem indicação em bula para determinada doença, o chamado uso *off label*:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento.

3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento.

4. A pretensão de inserir requisito diverso dos fixados no acórdão embargado para a concessão de medicamento não é possível na via dos aclaratórios, pois revela-se como mero inconformismo e busca de rejugamento da matéria.

5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA.

6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

(grifo nosso).

A vedação se fundamentou em interpretação da Corte Superior a respeito do disposto no art. 19-T da Lei nº 8080/90, que veda "*o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA*".

Nesse sentido, o parecer do NAT indica que o medicamento pleiteado não consta em bula para o tratamento do quadro clínico que acomete a autora, tampouco foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC para o tratamento da referida patologia.

Portanto, o medicamento requerido pela autora não foi autorizado pela ANVISA para o tratamento de sua enfermidade, hipótese em que a obrigatoriedade de seu fornecimento pelos entes públicos foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do referido Recurso Especial 1.657.156.

Dessa forma, a autora não comprovou o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156, para o fornecimento do medicamento pleiteado (Micofenolato de Mofetila 500mg).

Por fim, destaco que foi determinada a realização de perícia médica nos autos nº 5073304-35.2024.4.02.5101 (Ev. 54), de forma que a instrução processual encontra-se em andamento.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da autora, confirmando a decisão do Ev. 4 destes autos, a fim de manter a decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Após o trânsito em julgado, proceda-se à devida baixa. É como voto.